

中等运动量改善高脂血症患者不同中医体质血脂水平的队列研究

张钧华¹、王宁¹、戎杰²

1.陕西中医药大学 2.陕西中医药大学附属医院

目的：本研究以高脂血症患者为研究对象，通过推荐及制定个体化运动处方，观察运动对血脂、中医体质及健康状况的影响，为运动指导提供临床依据及理论支撑。

方法：根据纳排标准，于陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院和咸阳市第一人民医院体检管理中心纳入 120 例受试者，签署知情同意后，进行基本信息登记及量表测评，信息登记主要包括一般资料、疾病史、运动习惯等，量表包括中医体质量表、健康调查问卷 SF-36、IPQA 量表等。了解患者基本情况后，对受试者进行健康宣教，结合患者实际运动情况，给予患者运动推荐及指导，并提供进阶计划，运动干预共持续 1 个月。在运动 1 个月后进行空腹血脂检测及量表测评，同时记录 BMI、腰围指标。研究结束后，根据受试者运动量分为低运动量组、中运动量组、

高运动量组。记录相关数据并进行统计分析

结果：纳入 120 例受试者中有 98 例配合完成研究及运动，根据受试者的运动量分为三组，每组人数为低运动量组 59 人，中运动量组 39 人，高运动量组 0 人，故只对低中运动量两组进行分析。两组在性别、年龄、身高、体重等方面进行比较，差异无统计学意义 ($P>0.05$)，具有可比性。对运动前血脂水平、BMI、腰围、中医体质分布、中医体质评分、SF-36 量表评分、BMI 及腰围进行比较，差异无统计学意义 ($P>0.05$)，具有可比性。经过 1 个月的运动锻炼后，两组运动量差异具有统计学意义 ($P<0.001$)；中运动量组 TC、HDL-C 水平改善与低运动量组比差异有统计学意义 ($P<0.05$)，

且中运动量组运动后 TC、HDL-C 水平与运动前比改善显著，差异有统计学意义 ($P<0.05$)，两组 TG、LDL-C 水平在组间及运动后比较，差异无统计学意义 ($P>0.05$)；中运动量组平和质、气虚质、阳虚质及痰湿质评分改善较低运动量组差异有统计学意义 ($P<0.05$)，中运动量组运动后平和质、气虚质、阳虚质、痰湿质评分改善

较运动前比较差异有统计学意义 ($P < 0.05$)；运动后中运动量组中痰湿质 TC 水平、阳虚质 HDL-C 水平较低运动量组改善差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，中运动量组气虚质 LDL-C 水平较低运动量组改善差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。运动后中运动量组痰湿质 TC、TG 水平、阳虚质 HDL-C 水平、气虚质 LDL-C 水平较运动前改善差异有统计学意义 ($P < 0.05$)；中运动量组中的 PF、GH、VT、MH 评分较低运动量组明显改善，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。两组在运动后 PF、GH、VT、MH 评分显著提高，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。运动后中运动量组 PCS 及总分较低运动量组明显提高，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，PCS、MCS 及总分在两组运动后提高显著，均有统计学意义 ($P < 0.05-0.001$)；运动后两组 BMI、腰围比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)，运动后中运动量组 BMI、腰围较运动前降低显著，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。

结论：1. 中运动量运动可以明显降低高脂血症患者血脂中的 TC 水平、升高 HDL-C 水平。2. 高脂血症患者中医体质分布主要为痰湿质、阳虚质和气虚质；中运动量运动对高脂血症患者体质中的平和质、痰湿质、阳虚质和气虚质有明显的改善作用。3. 中运动量运动能在不同程度上改善高脂血症患者痰湿质、阳虚质及气虚质的血脂水平，其中痰湿质 TC、TG、阳虚质 HDL-C 及气虚质 LDL-C 水平明显改善。4. 中运动量运动可以提高高脂血症患者的 PF、GH、VT、MH、PCS、MCS 及总分水平，说明运动能够改善高脂血症患者的整体健康状况，改善生活质量。5. 中运动量可以降低高脂血症患者的 BMI、腰围水平。

联合运动对非酒精性脂肪性肝病人群中国内脏脂肪指数的影响

翟浩男¹、黄伟²、阮蔚淇²、庄洁²

1.浦东复旦附中分校 2.上海体育大学

研究目的：非酒精性脂肪性肝病 (Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) 是最常见的慢性肝病，从肝脏脂肪变性开始，可能演变为非酒精性脂肪性肝炎、肝硬化甚至肝细胞癌。其发病率在全球范围内不断上升，患病率约为25%，影响了约17亿人。